Cribado sistémico · Lumbar

PhysiQ-Assessment · fase 2. Lo que se pregunta siempre en lumbar. Las condiciones especiales, en la página siguiente. El porqué de cada pregunta, sus fuentes y «Ampliar con IA», en la guía de consulta (QR).

Porqués, fuentes e IA
v. 061d53f7

URGENCIAS HOY · CAUDA EQUINA
· Urgencia quirúrgica: el tiempo hasta la cirugía pesa más que la duración de los síntomas.
· Dolor o debilidad bilateral grave en MMII · parestesia en silla de montar · retención o incontinencia urinaria · incontinencia fecal · menor tono anal.
· PREGUNTAR SIEMPRE. Signos más específicos que sensibles; RM de elección. En mayores con estenosis el inicio lento se solapa y pasa desapercibido.

🔬 Cáncer / Oncológico

1. ¿Tiene antecedentes de cáncer de cualquier tipo?
2. ¿El dolor nocturno lo despierta desde un sueño profundo y le resulta imposible encontrar una posición que lo alivie?

🫘 Urogenital / Renal

1. ¿Ha notado cambios en la orina (color rojo, marrón, turbio) o fiebre/escalofríos junto con el dolor de espalda?
2. **¿Presenta incontinencia urinaria o intestinal, o pérdida de sensibilidad en la zona de "silla de montar"?** URGENCIA
3. ¿Tiene desde hace meses dolor en el sacro, el cóccix, el periné o el ano que empeora al estar sentado y se alivia tumbado, junto con molestias de orina, de heces o sexuales que ya tenía? DERIVACIÓN
4. ¿En las últimas 3–4 semanas ha notado ardor o dolor al orinar?
5. ¿Desde hace poco se levanta a orinar más de una vez cada noche, sin que haya cambiado lo que bebe antes de acostarse?
6. ¿Ha tenido un dolor muy intenso en el costado o la zona lumbar, que va y viene a oleadas y baja hacia la ingle o los genitales, con náuseas o vómitos?
7. ¿Tiene desde hace meses un dolor sordo en el costado o la zona lumbar izquierda que empeora de pie y mejora tumbado, y además le han encontrado sangre en la orina (aunque sea solo en un análisis), tiene varices en el lado izquierdo del escroto o, en mujeres, un dolor de pelvis que empeora de pie? DERIVACIÓN

🫃 Gastrointestinal

1. ¿El dolor lumbar, sacro o pélvico se alivia o cambia después de tener una evacuación intestinal o al expulsar gases?
2. ¿El dolor está relacionado con su ciclo menstrual, tiene sangrado inusual o dolor que alterna con dolor abdominal?
3. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en las heces, o dolor que lo despierta entre la medianoche y las 3 am?

🦴 Espondiloartropatías / Espondilogénicas / Ginecológico

1. ¿Tiene rigidez matutina prolongada (más de 30 minutos) que mejora con el movimiento?
2. ¿El dolor cambia de un glúteo a otro, unas veces en un lado y otras en el otro?
3. ¿El dolor sigue igual o empeora cuando descansa, en lugar de aliviarse?
4. ¿El dolor sacroilíaco lo despierta en la segunda mitad de la noche (entre las 2 y las 5 am)?
5. ¿El dolor pélvico está claramente relacionado con el ciclo menstrual, o tiene sangrado ginecológico inusual?
6. **(Mujeres en edad fértil) ¿Tiene un dolor de pelvis, abdomen bajo o espalda, nuevo o intenso, junto con un retraso de la regla, un sangrado vaginal inesperado, o mareo o desmayo?** URGENCIA
7. ¿Tiene diagnóstico de osteoporosis, o ha tenido una fractura reciente ante un golpe menor o sin trauma aparente?
8. ¿Ha notado deformidad ósea, engrosamiento de huesos o ha sido diagnosticado de enfermedad de Paget?
9. ¿Hace deporte o actividad vigorosa y repetitiva (p. ej. correr) y el dolor de nalga aparece con ella, con dieta pobre, alteraciones menstruales o fracturas de estrés previas?
10. ¿Ha aparecido de golpe dolor en ambas piernas durante el deporte, tras lesiones repetidas en extensión de la espalda?

Patrón compatible con dolor lumbar inflamatorio: derivación preferente a reumatología. — 2 o más de las preguntas 1, 4, 2, 3 · edad ≤ 45 · evolución: Crónico (>3 meses)

🫀 Vascular

1. ¿El dolor de piernas al caminar se le pasa con solo pararse de pie, sin necesidad de sentarse ni inclinarse?
2. ¿Tiene dolor lumbar o abdominal en reposo o por la noche, o le han notado un bulto que late en el abdomen?
3. ¿Nota un pie más frío que el otro, o le han dicho que tiene los pulsos de las piernas débiles?
4. **¿Le ha aparecido hace poco una pantorrilla o toda una pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
5. **Si se ha desmayado alguna vez: ¿fue mientras hacía un esfuerzo, estando tumbado, justo después de notar de golpe el corazón muy rápido, o con dolor en el pecho o falta de aire nuevos? ¿O algún familiar suyo murió de forma súbita antes de los 40 años?** URGENCIA

🦠 Infección vertebral

1. ¿Ha tenido fiebre o alguna infección en las últimas semanas, le han operado o infiltrado la espalda hace poco, o tiene las defensas bajas (corticoides, inmunosupresores, VIH, diabetes)?

⚗️ Endocrino / Metabólico

1. ¿Siente fatiga inusual o debilidad muscular, especialmente al subir escaleras o levantarse de una silla?
2. ¿Ha notado aumento anormal de sed, apetito o frecuencia urinaria (incluso despertándose por la noche)?
3. ¿Ha experimentado cambios recientes en su peso o tolerancia a la temperatura (mucho frío o calor cuando otros no)?
4. ¿Nota que sus heridas sanan muy lentamente o le aparecen moretones con excesiva facilidad?
5. (Si tiene diabetes) ¿Suele tener episodios de bajadas de azúcar, o siente ardor, entumecimiento o pérdida de sensibilidad en manos y pies?

🩸 Hematológico

1. ¿Sangra o se le forman moretones fácilmente después de un traumatismo menor, cirugía o procedimiento dental?
2. ¿Experimenta falta de aire, palpitaciones o dolor en el pecho con esfuerzos leves (subir escaleras) o en reposo?
3. ¿Padece infecciones recurrentes o fiebre baja frecuente (resfriados, gripe, infecciones respiratorias)?
4. **¿Está recibiendo tratamiento contra el cáncer (quimioterapia o radioterapia) y se encuentra mal o tiene fiebre?** URGENCIA
5. **(Si tiene hemofilia u otro trastorno hereditario de la coagulación) ¿Tiene un dolor nuevo en una articulación o un músculo, con hormigueo o tirantez, hinchazón, calor o dificultad para moverla?** URGENCIA
6. ¿Ha notado heces negras/alquitranadas, sangre en orina, o ha tosido o vomitado sangre?

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

Condiciones especiales · Lumbar

Solo se preguntan si el paciente tiene la condición (en la app, su tarjeta de la fase 1 marcada, o el mecanismo «Post-quirúrgico»). La escala de Beighton, la sospecha del subtipo vascular, la prueba de bipedestación, la regla de la tensión en el embarazo y la tensión tumbado y de pie del Parkinson se calculan en la guía (QR).

🏥 Posquirúrgico

Solo con mecanismo «Post-quirúrgico» en la fase 1

1. **¿Desde la operación, la herida está más roja, caliente, hinchada o dolorosa, supura o se ha abierto, o ha tenido fiebre, escalofríos o malestar general?** URGENCIA
2. **¿Desde la operación tiene una pantorrilla o una pierna hinchada, caliente o dolorosa? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le falta el aire de repente, le duele el pecho al respirar, ha tosido sangre o se ha mareado o desmayado?** URGENCIA
4. **¿Desde la operación de columna nota en los brazos o las piernas un dolor, hormigueo, adormecimiento o pérdida de fuerza nuevos o que van a más, torpeza al caminar, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA

🧬 Hipermovilidad

Solo con tarjeta «Hipermovilidad / Ehlers-Danlos» marcada

1. **¿Ha tenido de forma brusca un dolor intenso, que va a más, en el abdomen, el flanco, la espalda, el pecho o un brazo o una pierna?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
2. **¿Ha notado de repente un zumbido en la sien, con el ojo rojo, dolorido o más saltón?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
3. **¿Le ha faltado el aire de forma brusca, o le duele el pecho al respirar?** URGENCIA
   con «Sospecha», subtipo vascular o la regla de sospecha vascular cumplida
4. ¿Algún familiar de primer grado con SED vascular, o con una rotura o disección arterial antes de los 40 años?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
5. ¿Ha tenido una rotura arterial o una rotura de intestino sin causa conocida?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
6. ¿Ha tenido algún neumotórax espontáneo?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
7. ¿Le salen hematomas sin golpes, en sitios poco habituales (mejillas, espalda), o tiene la piel fina y translúcida, con las venas muy visibles?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)
8. ¿Tuvo varices antes de los 30 años (y, si es mujer, sin haber estado embarazada)?
   con «Sospecha», o «Diagnosticada» sin subtipo conocido (otro, no lo sabe o sin marcar)

🫀 Disautonomía

Solo con tarjeta «Disautonomía / POTS» marcada

1. **¿Se ha desmayado alguna vez mientras hacía un esfuerzo (no justo al pararlo)?** URGENCIA
2. **¿Se ha desmayado estando tumbado, o justo después de notar de golpe el corazón muy rápido?** URGENCIA
3. **Si se ha desmayado: ¿tenía a la vez dolor en el pecho o falta de aire nuevos, o le han dicho que tiene un soplo, insuficiencia cardiaca u otra enfermedad del corazón?** URGENCIA
4. **Si se ha desmayado: ¿algún familiar murió de forma súbita antes de los 40 años, o tiene una enfermedad del corazón hereditaria?** URGENCIA
5. ¿Le dan episodios en que el corazón se le dispara de golpe y se le para también de golpe, aunque esté sentado o tumbado, sin llegar a desmayarse? DERIVACIÓN

🦋 Lupus

Solo con tarjeta «Lupus (LES)» marcada · solo «Diagnosticado»

1. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra mal en general de una forma nueva? (Con corticoides o inmunosupresores puede haber una infección sin fiebre.)** URGENCIA
2. **¿Tiene una pantorrilla o una pierna (o un brazo) hinchada, caliente o dolorosa de forma nueva? (Posible TVP: calcular Wells; ≥2 → probable.)** URGENCIA
3. **¿Le ha faltado el aire de repente o le duele el pecho al respirar? ¿O ha tenido de golpe debilidad o adormecimiento de un lado, dificultad para hablar o pérdida de visión, aunque se le haya pasado?** URGENCIA
4. **¿Tiene un dolor en el pecho punzante que empeora al respirar hondo y mejora inclinándose hacia delante?** URGENCIA
5. **¿Tiene en algún dedo de la mano o del pie una herida o úlcera en la yema, o un dedo que se queda blanco o morado y no recupera el color?** URGENCIA
6. **¿Ha tenido una convulsión o confusión nueva; debilidad u hormigueo en las dos piernas que va a más, con cambios al orinar; de golpe, el pie o la mano caídos; o pérdida de visión?** URGENCIA
7. ¿Tiene un dolor profundo y persistente en la ingle, la rodilla, el hombro o el tobillo, que empeora al cargar o al andar y no se explica por un golpe? DERIVACIÓN
8. ¿Le cuesta cada vez más levantarse de una silla, subir escaleras o levantar los brazos por encima de la cabeza? DERIVACIÓN
9. Desde la última vez que le vio su reumatólogo, ¿tiene articulaciones hinchadas nuevas, una erupción, llagas en la boca o más caída de pelo? DERIVACIÓN
10. ¿Se le hinchan las piernas o los tobillos de forma nueva, le han dicho que tiene la tensión alta desde hace poco, o en un análisis que tiene proteínas o sangre en la orina? DERIVACIÓN

💉 Trastorno mastocitario o anafilaxia

Solo con tarjeta «Trastorno mastocitario o anafilaxia» marcada

1. Desde su última revisión médica, ¿ha tenido episodios bruscos con ronchas, hinchazón, falta de aire, mareo o desmayo que su médico aún no conoce? DERIVACIÓN

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0

🦴 Osteoporosis

Solo con tarjeta «Osteoporosis o fragilidad ósea» marcada

1. **¿Tiene un dolor de espalda nuevo con debilidad, hormigueo o torpeza en las piernas que va a más, o cambios al orinar o al hacer de vientre?** URGENCIA
2. ¿Le empezó de golpe un dolor de espalda, sobre todo en la zona dorsal, tras un esfuerzo pequeño (levantar algo agachado, toser, estornudar, resbalar), y no se le ha ido? DERIVACIÓN
3. ¿Ha perdido 4 cm o más de altura respecto a cuando era joven (o 2 cm desde la última vez que se la midieron), o se le ha curvado más la espalda? DERIVACIÓN *sin fractura vertebral conocida*
4. ¿Tiene un dolor de muslo, ingle o cadera sin explicación? DERIVACIÓN *con bifosfonato o denosumab*

🤰 Embarazo y posparto

Solo con tarjeta «Embarazo o posparto» marcada

1. **¿Tiene dolor de cabeza fuerte o que no se le pasa, ve borroso o destellos, dolor fuerte justo debajo de las costillas, vómitos, o se le han hinchado de golpe la cara, las manos o los pies?** URGENCIA *embarazo desde la semana 20 o posparto*
2. **¿Ha tenido un sangrado vaginal que no le han explicado?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 13*
3. **¿Nota que el bebé se mueve menos de lo habitual?** URGENCIA *solo embarazo desde la semana 24*
4. **¿Tiene contracciones regulares y dolorosas, o le sale líquido por la vagina?** URGENCIA *solo embarazo*
5. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o se encuentra muy mal?** URGENCIA *solo embarazo*
6. **¿Tiene un sangrado vaginal brusco o muy abundante, que va a más, o expulsa coágulos o restos? ¿O se le ha hinchado mucho el vientre?** URGENCIA *solo posparto*
7. **¿Tiene fiebre o escalofríos, o dolor de vientre, pelvis o periné, o un flujo que huele mal?** URGENCIA *solo posparto hasta la semana 8 tras el parto*
8. **¿Tiene dolor e hinchazón nuevos en una pierna, sobre todo en una sola; o dolor de espalda o de nalga con toda la pierna hinchada; o le falta el aire de forma nueva, le duele el pecho o ha tosido sangre?** URGENCIA
9. **¿Tiene dolor en el pecho, palpitaciones, o le falta el aire en reposo o al tumbarse?** URGENCIA
10. **¿Se le ha abierto la herida del periné o la de la cesárea, o tiene más dolor, rojez o supuración en ella?** URGENCIA *solo posparto*
11. **¿Desde el parto se le escapa la orina o las heces de forma continua, sin poder controlarlo nada?** URGENCIA *solo posparto*
12. **(Si hace falta, al acompañante) ¿Ha notado cambios bruscos desde el parto: confusión, ideas extrañas, euforia o mucha agitación?** URGENCIA *solo posparto*
13. **¿Ha pensado en hacerse daño o en quitarse la vida?** URGENCIA
14. ¿Tiene un dolor de espalda intenso y que no se le pasa, dorsal o lumbar, en el embarazo o desde el parto, o ha perdido 3 cm o más de altura? DERIVACIÓN
15. ¿Desde el parto tiene un dolor intenso o que empezó de golpe en la sacroilíaca, la nalga, la zona lumbar o el pubis, le cuesta apoyar o cojea, o se le alivia tumbada? DERIVACIÓN *solo posparto hasta la semana 2 tras el parto*
16. ¿Tiene un pecho rojo e hinchado desde hace más de 24 horas, aunque se lo haya tratado? DERIVACIÓN *solo posparto*

🩸 Anticoagulado o antiagregado

Solo con tarjeta «Paciente anticoagulado o antiagregado» marcada

1. **¿Se ha dado un golpe en la cabeza en los últimos días, aunque pareciera leve?** URGENCIA *no con aspirina sola*
2. **Desde un golpe en la cabeza (de hace días o semanas), ¿tiene un dolor de cabeza fuerte o que va a más, vómitos repetidos, somnolencia, confusión o cambios de conducta, o debilidad, dificultad para hablar o cambios de visión nuevos?** URGENCIA
3. **¿Le ha empezado de golpe un dolor fuerte de cuello o de espalda con debilidad, hormigueo o adormecimiento en brazos o piernas, o cambios al orinar o al hacer de vientre? (Puede empezar por la debilidad, sin dolor fuerte.)** URGENCIA
4. **¿Le ha empezado un dolor fuerte en la ingle, la cadera, el costado o la zona lumbar baja, con el muslo débil o adormecido, o con mareo, palidez o sudor frío? (Con un golpe pequeño o sin golpe.)** URGENCIA *solo con anticoagulante*
5. **¿Le ha salido de golpe, tras toser, un esfuerzo o una inyección de heparina, un dolor fuerte en la pared de la barriga con un bulto, que empeora al moverse o al tensar el abdomen?** URGENCIA *solo con anticoagulante*
6. **¿Tiene un brazo, un antebrazo, una mano, un muslo o una pierna muy hinchados y tensos, con un dolor desproporcionado que va a más y que empeora al estirarle pasivamente los dedos de la mano o del pie? (Tras un golpe pequeño, un esfuerzo o sin causa.)** URGENCIA
7. ¿Tiene un hematoma grande o que va a más, un bulto nuevo en un músculo, o una articulación hinchada tras un golpe pequeño o sin golpe? DERIVACIÓN

🧠 Parkinson

Solo con tarjeta «Parkinson» marcada

1. **En los últimos días, ¿está mucho más rígido o inmóvil que de costumbre y además tiene fiebre, está confuso, suda mucho o le cuesta tragar?** URGENCIA *solo «Diagnosticado»*
2. ¿Ha dejado de tomar su medicación del Parkinson, o no puede tomarla o retenerla (vómitos, diarrea, no puede tragar, una cirugía)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
3. ¿Han vuelto de golpe el temblor, la rigidez o la lentitud, o tiene movimientos involuntarios fuertes o cambios de conducta nuevos? DERIVACIÓN *con estimulador cerebral profundo*
4. ¿Tiene periodos off que no sabe prever, movimientos involuntarios fuertes o calambres dolorosos cuando está en off? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
5. ¿Ve cosas que no están, o tiene conductas nuevas que no puede controlar (tomar medicación de más, juego, compras, comida)? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
6. ¿Se marea, ve borroso, nota las piernas flojas o le duele el cuello y los hombros al estar de pie, y se le pasa al sentarse o tumbarse? DERIVACIÓN
7. ¿Tose o se atraganta al comer o beber, o ha tenido infecciones respiratorias seguidas? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
8. ¿Se queda dormido de repente durante el día, sin poder evitarlo? DERIVACIÓN *solo «Diagnosticado»*
9. Temblor, rigidez, lentitud, problemas de equilibrio o de la marcha, sin diagnóstico DERIVACIÓN *solo «Sospecha»*

URGENCIA derivar hoy · DERIVACIÓN valoración médica, no urgente · *gris* cuándo aparece la pregunta

Un SÍ aislado no implica derivación automática (salvo URGENCIA y DERIVACIÓN): evaluar en el contexto clínico. Las preguntas son las de la app, literales; las banderas rojas y amarillas, las zonas de dolor referido y el impacto en el descanso y el ejercicio de cada sistema, en la guía (QR).

Generado desde los datos de la app el 6/11/2026.

PhysiQ · Edu Gamboa, fisioterapeuta · physiodevapp.github.io/physiq · © 2026 · CC BY-NC-ND 4.0